جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : عزة محمد عبدالعال تاج الدين

المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** امبابه **العنوان :** ----------

رقم البطاقة : 27001032101761 **رقم التليفون :** 01001733220 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 15-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 03-01-1970 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**

التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: عزة محمد عبدالعال تاج الدين
National ID: 27001032101761

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Bilateral mammogram and breast ultrasound**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



عزه
محمد عبدالعال تاج الدين
قرية ناهيا
مركز كرداسة - الجيزه

٢٧٠٠١٠٣٢١٠١٧٦١

J27581432



٢٠٢٣/٠٥

٢٧٠٠١٠٣٢١٠١٧٦١

ربة منزل

انثى مسلمة متزوجة

كمال محمد إبراهيم تاج الدين

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٣/٠٥/١٩

١



National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : عزه محمد عبدالفتاح تاج الدين Sex: 3- Medical number: 83138271 Female Old Med : 1473-2023

2-ID number: 27001032101761 Patient Age : 54 Y

Family history		Phone	01121334964	BMI		REASON OF MDT	
marital status		NRS Score		GROUP		Date of MDT	2023-11-25
Co morbidity	+ve	Menopausal status		Initial STAGE			

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :
ct cap:free

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	KI67
IDC	8/8	6/8	3		

T	N	M
4b	1	0

Sonomammography
rt breast locally advanced multicentric malignant looking mass with multiple pathologica l rt axillary
lymphadenopathy (BIRADS 5)

PATIENT HISTORY
pt received 18 wks TC + 3 cycles phesgo ended 12/10
RT MRM:
IDC GII
free nipple ,areola
LN +ve 2/13 withncapsular invasion
partial pathological response

MDT OUTCOME & PLAN

for adjuvant Kadcyla 12 cycles / adjuvat aramidex/ PORT

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Name: عزة محمد عبد العال تاج الدين **MR. :** 744	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتها

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها

The patient was diagnosed in 2023 with right breast invasive ductal carcinoma grade II, with a pathologic partial response to neoadjuvant chemotherapy. The mastectomy specimen showed free nipple and areola, free deep margin, and 2 of 13 lymph nodes positive with capsular invasion. The staging was ypTlc(m), ypNIa IPT. Immunohistochemistry revealed ER positive (score 8/8), PR positive (score 6/8), and HER2 positive (score 3+). The current management plan includes arimidex with supportive care for 3 months, with the next clinic visit scheduled for 5/9/2026.

تحريرا في ,

التاريخ :	**20-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : نهي سعيد علي محمد

يعتمد ,

Patient Name	:الأستاذه / جزء محمود عبدالعال تاج الدين	Request No.	:13000035
Patient No.	:27001032101761	Request Date	:02/11/2023
ath No.	:3807/23	Verification Date	:13/11/2023
Sex	:Female	Financial Category	: أورام دار السلام - تغطية الدولة
Age	:53 Y	Department	:Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	:.marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Right breast cancer post NACT .

Nature of the specimen:
Right MRM specimen collected at 2/11/23.

Gross Examination:
Right MRM measured 25x25x5 cm with covering skin ellipse measured 25x15 cm .Serialling revealed two grey white rubbery masses.The first mass measured 1.4x1.2 cm located in UOQ .The second mass measured 1x0.8 cm , located 4 cm away from the first one.Rest of breast tissue showed dilated ducts oozing yellowish pasty material.
- Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly .
- Distance from margins: 3 cm away from deep margin .
- Lymph nodes number and size:13 L.Ns up to 2.5x2 cm .

Microscopic examination:
- Histological type: Bifocal invasive duct carcinoma.
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1).
- Ductal carcinoma in situ: Focal (10%)
- Angioinvasion:Positive.
- Skin involvement: Free nipple and areola.
- Lymph node involvement:Positive (2/13) with capsular invasion.
- Resection Margins: Free deep margin ..
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response

Diagnosis:
Right breast cancer post NACT , MRM specimen :
-Invasive duct carcinoma grade II .

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

atient Name	:الأستاذة / مرء محمود عبدالعال تاج الدين	Request No.	: 13000035
Patient No.	:27001032101761	Request Date	: 02/11/2023
Path No.	:3807/23	Verification Date	: 13/11/2023
Sex	:Female	Financial Category	: أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	:53 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

-Free nipple and areola.
-Free deep margin.
- Lymph nodes:Positive (2/13) with capsular invasion
-Pathologic partial response
-Stage : ypT1c(m) , ypN1a
-RCB : 3.093 , RCB class II.

Prof.Gamal Abdelatiy
Dr.Duaa Mohammed

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

PATIENT NAME: AZZA MOHAMMED ABDELAAL TAG ELDEEN GENDER: Female AGE: 53 y	PATIENT ID #: 10123223523 ORDER #: 2257468,2257469 DATE OF SERVICE: 15-Apr-2023 02:54 PM

Report: - all studies

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS

1-CHEST:

- Known patient with breast cancer, with right breast multiple irregular masses, the largest is measured 3.2x3.6cm, along with pathological right axillary level I, II and III LNs, the largest is axillary, measured 2x2.4cm
- Left lung ting nodules, the largest is measured 2mm, yet no sizable pulmonary masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No CT evidence of pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers.
- No pericardial effusion detected.
- Hiatus hernia.

2- ABDOMEN AND PELVIS:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation..
- Patent homogeneously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- Normal appearance of the pancreas, spleen (with splenic calcifications), kidneys, adrenals, aorta, I.V.C and the pelvic organs.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- No pathologically enlarged abdominal or pelvic lymph nodes.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Average AVF uterus with IUD is seen insitu.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

- The revised bone window revealed:
1. No destructive lytic osseous lesions.
2. Double level 1st degree lytic spondylolithosis of L4 and L5 vertebrae.

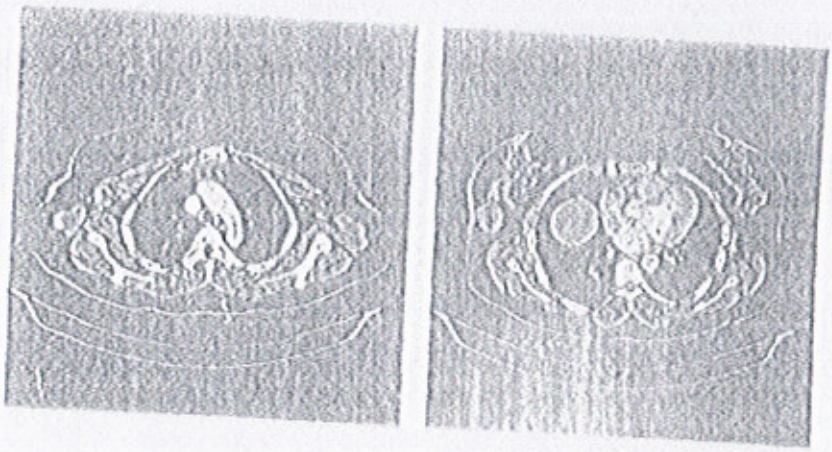
Opinion:

- Right breast malignant process with pathological right axillary level I, II and III LNs.
- No CT evidence of sizable pulmonary, hepatic or osseous metastatic lesions.

Reported By,

Dr. Engy Abdullah
Dr. Mahmoud Saleh, MD

16-Apr-2023 01:14 PM



CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]